BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN Phòng Điều dưỡng	QUY TRÌNH CHUẨN (SOP) NHẬN ĐỊNH, PHÂN CẤP CHĂM SÓC VÀ LẬP KẾ HOẠCH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH	Mã số: SOP-C6.3-01 Lần ban hành: 01 Ngày hiệu lực: …/…/2026 Số trang: theo bản in

	Người biên soạn	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ tên			
Chức danh	Điều dưỡng Phòng Điều dưỡng	Trưởng phòng Điều dưỡng	Giám đốc
Chữ ký			
Ngày			

Lần	Ngày	Nội dung sửa đổi
01		Ban hành lần đầu

DỰ THẢO

1. Mục đích

Bảo đảm mọi người bệnh nội trú được nhận định toàn diện, đánh giá nguy cơ, phân cấp chăm sóc đúng và có kế hoạch chăm sóc cá thể hóa ngay từ khi nhập khoa; được lượng giá và điều chỉnh liên tục đến khi ra viện.

2. Phạm vi áp dụng

Tất cả khoa lâm sàng có người bệnh điều trị nội trú. Không áp dụng cho người bệnh điều trị ngoại trú.

3. Trách nhiệm

- Điều dưỡng, hộ sinh được phân công: thực hiện các bước 1–9.
- Bác sĩ điều trị: cùng xác định cấp chăm sóc (bước 4), ký xác nhận.
- Điều dưỡng trưởng khoa: phân công, kiểm tra người bệnh Cấp I hằng ngày, giám sát hằng tuần bằng BM-C6.3-03.
- Phòng Điều dưỡng: tập huấn, giám sát hằng tháng, tổng hợp chỉ số.

4. Định nghĩa, chữ viết tắt

- NB: người bệnh; ĐD: điều dưỡng; ĐDT: điều dưỡng trưởng; HSBA: hồ sơ bệnh án; DHST: dấu hiệu sinh tồn.
- ISBAR: Identify (xác định NB) – Situation (tình trạng) – Background (tiền sử) – Assessment (nhận định) – Recommendation (đề xuất).

- Morse: thang đánh giá nguy cơ té ngã; Braden: thang đánh giá nguy cơ loét tỳ đè; NRS: thang điểm đau số 0–10.

5. Nội dung quy trình

Bước	Nội dung thực hiện	Người thực hiện	Thời gian	Hồ sơ
1	Tiếp nhận NB; xác định NB bằng 02 thông tin nhận dạng theo SOP-D2.4; kiểm tra vòng nhận dạng; đo DHST, cân nặng, chiều cao	ĐD tiếp nhận	Ngay khi NB đến khoa	Phiếu chăm sóc
2	Nhận định toàn diện 11 lĩnh vực: ý thức, hô hấp, tuần hoàn, dinh dưỡng, bài tiết, vận động, da – niêm mạc, giấc ngủ, đau, tâm lý, tiền sử dị ứng; nhu cầu GDSK	ĐD được phân công	Trong 8 giờ đầu	BM-C6.3-01
3	Đánh giá nguy cơ: Morse, Braden, sàng lọc dinh dưỡng, điểm đau	ĐD được phân công	Morse, Braden: 8 giờ đầu; dinh dưỡng: 36 giờ đầu	BM-C6.3-01
4	Cùng bác sĩ xác định cấp chăm sóc I, II, III; ghi HSBA, phiếu chăm sóc, bảng tổng hợp cấp chăm sóc của khoa	Bác sĩ, ĐD	Trong 8 giờ đầu	HSBA, BM-C6.3-01
5	Xác định chẩn đoán điều dưỡng ưu tiên; đặt mục tiêu đo được, có thời hạn; lập can thiệp; thông báo kế hoạch cho NB, người nhà	ĐD được phân công	Trong 24 giờ đầu (Cấp I, II)	BM-C6.3-02
6	Thực hiện chăm sóc và gói phòng ngừa theo nguy cơ: té ngã (giường thấp, chắn song, chuông gọi, đi kèm khi vệ sinh); loét (đổi tư thế 2 giờ/lần, đệm giảm áp, chăm sóc da); dinh dưỡng (báo Tổ dinh dưỡng); đau (thực hiện y lệnh, đánh giá lại)	ĐD, hộ lý	Liên tục	Phiếu chăm sóc
7	Lượng giá kết quả; điều chỉnh kế hoạch và cấp chăm sóc khi diễn biến thay đổi; đánh giá lại nguy cơ theo QĐ-C6.3 Điều 5	ĐD được phân công	Ít nhất mỗi ngày	BM-C6.3-02
8	Bàn giao ca theo ISBAR, nêu rõ NB Cấp I và NB nguy cơ cao; ĐDT kiểm tra NB Cấp I	ĐD, ĐDT	Mỗi ca; ĐDT hằng ngày	Sổ bàn giao
9	Khi ra viện: GDSK ra viện (dùng thuốc, dinh dưỡng, vận động, dấu hiệu nguy hiểm, lịch tái khám), lượng giá hiểu biết NB, tổng kết chăm sóc	ĐD được phân công	Ngày ra viện	Phiếu chăm sóc

6. Tiêu chuẩn đánh giá

- ≥ 95% NB nội trú được phân cấp chăm sóc (KPI-C6.3-01).
- ≥ 95% NB Cấp I, II có kế hoạch chăm sóc trong 24 giờ đầu (KPI-C6.3-02).
- ≥ 95% NB được đánh giá đủ nguy cơ té ngã, loét, dinh dưỡng đúng hạn (KPI-C6.3-04).

- ≥ 90% hồ sơ chăm sóc đạt khi giám sát bằng BM-C6.3-03 (KPI-C6.3-03).

7. Hồ sơ, biểu mẫu

Mã	Tên hồ sơ	Nơi lưu	Thời gian lưu
BM-C6.3-01	Phiếu nhận định ban đầu và phân cấp chăm sóc	Trong HSBA	Theo HSBA
BM-C6.3-02	Kế hoạch chăm sóc cá thể hóa	Trong HSBA	Theo HSBA
BM-C6.3-03	Bảng kiểm giám sát chăm sóc toàn diện	Khoa, Phòng Điều dưỡng, phần mềm NT Nursing	03 năm

8. Tài liệu tham khảo, căn cứ

- Thông tư số 31/2021/TT-BYT quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
- Thông tư số 32/2023/TT-BYT, Phụ lục XII được sửa đổi bởi Thông tư số 25/2026/TT-BYT.
- Thông tư số 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.
- Thông tư số 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa.
- Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 (Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam).
- Quy định chăm sóc người bệnh toàn diện QĐ-C6.3; Quy trình phòng ngừa té ngã của bệnh viện; SOP-D2.4 xác định người bệnh.